PROTOCOLLO 31

Gestione dello spostamento discale con riduzione

Ridurre i sintomi e migliorare il controllo del movimento in presenza di click

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Spostamento discale con riduzione	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Click reciproco doloroso
- ✓ Deviazione a S in apertura
- ✓ Fastidio in masticazione

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo

1



FASE 1

Educazione

Spiega che il click è frequente e spesso benigno.

2



FASE 2

Controllo

Insegna l'apertura retta con lingua al palato.

3



FASE 3

Terapia manuale

Distrazione e scivolamento delicati se c'è dolore.

4



FASE 4

Esercizio

Allenamento del controllo motorio senza click.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I e II
Esercizio	10 ripetizioni senza click
Frequenza	2 sedute a settimana

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ L'obiettivo è un movimento senza dolore, non eliminare il click
- ✓ Rassicura il paziente
- ✓ Lavora sul controllo motorio

Errori da evitare

- ! Tentare di riposizionare il disco con manovre forzate
- ! Allarmare il paziente
- ! Ignorare episodi di blocco

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura controllata	Aprire con lingua al palato fino al limite senza click	10 ripetizioni, 3 volte al giorno

! **Nota clinica.** Episodi di blocco in chiusura vanno monitorati e comunicati all'odontoiatra.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.